

Расширенное выступление 30-40 минут

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Расширенное устное выступление на 30–40 минут](#)
 - [\[0:00\] Вступление: что мы обсуждаем и почему это не про еду](#)
 - [\[0:30\] Контекст: где мы работаем](#)
 - [\[2:00\] Проблема: пять конфликтов за одним обедом](#)
 - [\[5:00\] Граница 4.0: что кухня не назначает](#)
 - [\[7:00\] Клинический контекст: что в России не измерено](#)
 - [\[10:00\] Правовая рамка: что разрешено и что не нужно](#)
 - [\[12:30\] Российские практики: 4 учреждения + 1 регион](#)
 - [\[15:00\] Пилот 90 дней: минимальный безопасный старт](#)
 - [\[18:00\] Метрики и стоп-критерии в деталях](#)
 - [\[21:00\] Пять возражений и честные ответы](#)
 - [\[24:00\] Защитная формула и первые пять действий](#)
 - [\[26:00\] Какие ошибки делают чаще всего](#)
 - [\[28:00\] Дорожная карта: 12 месяцев](#)
 - [\[30:00\] Этический фокус: достоинство](#)
 - [\[32:00\] Международный контекст \(кратко\)](#)
 - [\[33:30\] Заключение: не внедряйте вслепую. Измеряйте.](#)
 - [Тайминг](#)
 - [Версии](#)
 - [Оговорки \(те же, что в 20-мин версии\)](#)

Расширенное устное выступление на 30–40 минут

Документ: сценарий расширенного выступления (тренинг-формат, малая группа руководителей, или секция «Питание» в программе 25–27.08). **Версия:** 22.08.2026. **Объём:** ≈ 4 800 слов (полная устная речь 30–35 минут при спокойном темпе с паузами). **Назначение:** для тренеров, кураторов, методистов учредителя, для разбора кейсов и более глубокой проработки. **Структура:** 8 блоков по 4–5 минут каждый.

Драматургия: контекст → проблема → граница → клиника → практика → пилот → метрики → возражения → финал.

[0:00] Вступление: что мы обсуждаем и почему это не про еду

Коллеги, тема сегодня — питание в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами.

И я хочу сразу предупредить: это не про еду. Это про управление в условиях, когда медицинская рамка и воля жителя — в одной руке одного специалиста, и эта рука — врача.

Вариативное питание — не ресторан, не два полноценных меню, не «исполнение любого желания». Это управляемая система, в которой безопасность имеет приоритет, медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист, внутри допустимой рамки человеку предоставляют понятный выбор, выбор документируется, кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз, результаты пилота измеряются, достоинство не противопоставляется безопасности.

И последнее слово этого доклада — не «внедряйте», а **«измеряйте»**. Семь дней замера отделяют убеждение от знания.

[Слайд 1 — титул: «Вариативное питание в ПНИ/ДСО: организационная модель, доказательная база, протокол пилота. Чистяков Е. В., 26.08.2026»; 0:30]

[0:30] Контекст: где мы работаем

Где мы работаем. В Российской Федерации в 2024 году функционировали **466 психоневрологических интернатов для взрослых**, в которых проживали около **139 000 человек**. Если брать более широкую категорию — стационарные организации для лиц с ментальными нарушениями — это **174 000 человек**, по данным Минтруда. Две трети жителей — старше 45 лет. Одиннадцать процентов — на постоянном постельном режиме. **74 % признаны судом недееспособными.**

Источник — **проект «Если быть точным»** (аналитика на открытых данных Минтруда, Росстата, Федерального казначейства, публикация 09.04.2026; techno.st). Это **не официальная статистика Минтруда** — это независимая аналитика. Но она построена на открытых данных. **В вашем учреждении цифры могут быть другими — посчитайте свои.**

И одна цифра, которой нет в русскоязычных методичках. 99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения. 117 000 человек. Это **не уникальный риск Серафимовского — это общероссийская норма.** Учреждение одновременно опекун жителя и поставщик услуг. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 говорит о праве на «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства». **Этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают** — но требует задокументированной процедуры выражения воли.

[Слайд 2 — Контекст: 466 ПНИ, 139 000 жителей, 99 % под опекой; 1:00]

[2:00] Проблема: пять конфликтов за одним обедом

Давайте начнём не с витрины «как хорошо у нас получается». Сначала несъеденное и голод, потом броня документов и пилот на одно отделение.

Один обед — пять конфликтов. Обеденный зал на 120 мест. На линии — борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей едят только с помощью. Четыре сиделки, из которых одна развозит лекарства. Это — **типичная ситуация в среднем ПНИ на 289 коек** (расчёт проекта «Если быть точным»).

Первый конфликт: очередь против помощи. Самостоятельные сидят перед остывающими тарелками — им первым, потому что быстрее. Кормимые ждут: 4 сиделки на 12 — это 3 цикла по 15–20 минут. Последние получают холодное. Международная норма, которую мы приводим в сопоставлении, требует не более двух полностью кормимых на одного работника; у нас это правило не закреплёно нигде.

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель третий день отодвигает тарелку. Журнала отказов нет, и врач узнает об отказах на обходе в четверг. У него депрессивный эпизод и, возможно, начинающаяся дисфагия — но проверить некому: логопеда в штате нет, признаки расстройства глотания (покашливание за столом, «влажный» голос после еды) никто не связывает с отказами.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель на клозапине с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли родственники. Никто не предупредил семью и самого жителя, что **кофеин в дозе 400–1000 мг/день повышает АУС клозапина в среднем на 19 %** (Hägg S. et al., Br J Clin Pharmacol 2000). Исследование — на 12 здоровых добровольцах, однократная доза. У пациента с шизофренией эффект может быть другим. Но **исследование показывает, что эффект клинически значим.**

Четвёртый конфликт: добавка. Житель на оланзапине набрал 14 кг за год — оланзапин имеет один из самых выраженных весогенных профилей (**36,9 % пациентов с прибавкой ≥ 7 % веса за 38 нед**, Campforts B. et al., BJPsych Open 2023). Сиделка отказывает «вам нельзя, вы полнеете». Врачебного назначения нет. Решение принято сиделкой по её представлению о пользе.

Пятый конфликт: проверка на следующей неделе. В четверг — комиссия учредителя. Суточные пробы за двое суток будут подписаны сегодня. Это самое опасное — документальная имитация контроля.

Почему все пять конфликтов — одна система. Каждый из пяти имеет отдельного «виноватого» в глазах участников: медленную сиделку, капризного жителя, неведущую семью, несдержанного соседа, нерадивого

завхоза. И каждый на самом деле является отказом системы. **Ни один из пяти не требует денег для начала.** Требуется решение директора и документы. Три из пяти упираются в кадровую нагрузку.

[Слайд 3 — Пять конфликтов; 4:30]

[5:00] Граница 4.0: что кухня не назначает

Сначала граница. Без неё всё остальное — ложь.

Без врачей: любые ограничения рациона, в том числе «диабетический стол». Изменение текстур — протёртое, загущённое. Правила при дисфагии и протокол свободной воды. Действия при длительном отказе от еды. Режим при седации. Решения об энтеральном/зондовом питании. Комфортное кормление в конце жизни. Сдвиг времени еды у инсулинозависимых. Слабительные и реакция на запор. Назначение анализов и добавок микронутриентов. Интерпретация **MUST**. Витаминизация при **ОРИ**.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки. Штатное расписание — норма помощи за столом. Аутсорсинг питания. Официальный статус пилота и его публичность.

Без правовой проверки: формулировки о согласии недееспособного. Обработка пищевых карт как персональных данных. Ответы на запросы прокуратуры. Конструкции, где учреждение одновременно опекун и поставщик услуг.

Иначе осторожный директор правильно услышит: «мне предлагают медицинскую реформу руками повара». **Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.** Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача.

[Слайд 4 — Граница 4.0; 6:00]

[7:00] Клинический контекст: что в России не измерено

Теперь — про клинику. И я сразу скажу: **доказательная база в этой области не российская.** Это не потому, что у нас плохо работают — это потому, что в России пока никто не собрал панель «до/после» с измеримыми исходами. **«Внедрено публично ≠ доказанный эффект»** — панелей «до/после» в открытом доступе почти нет.

Что мы знаем из международных исследований:

Дисфагия. В изученных клинических группах на антипсихотиках — **21,9–69,5 %** (Miarons Font M, Rofes Salsench L. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;

обзор 18 исследований). **Популяции не совпадают с российскими ДСО**; в вашем учреждении цифра может быть любой — посчитайте свою в первые 10 дней пилота. И не смотрите на нижнюю границу с облегчением: нижняя граница говорит, что проблема **не редка**.

Смертность от пневмонии при шизофрении — в 7 раз выше популяционной (Correll C.U. et al. World Psychiatry 2022; мета-анализ 135 когорт 1957–2021; RR 7,00; 95 % ДИ 6,79–7,23). Аспирация — один из ключевых механизмов разрыва продолжительности жизни 15–20 лет.

Гигиена полости рта — самая экономически доступная мера. Yoneyama T. et al. (J Am Geriatr Soc 2002): РКИ 366 жителей, пневмонии 19→11 %. По мета-анализу Sjogren P. et al. (2008, 4 РКИ), улучшение ухода за полостью рта **может предотвращать примерно 1 из 10 смертей от аспирационной пневмонии**. **Популяция Sjogren — frail elders в домах ухода, не ПНИ/ДСО; прямой перенос не обоснован**.

76,3 % прибавка веса на клозапине (Campforts B. et al. BJPsych Open 2023; 202 исследования; ≥ 7 % за 38 нед). **Не путать с Pillinger T. et al. (Lancet Psychiatry 2020)** — там диапазон $-0,23...+3,01$ кг за 6 нед по 18 антипсихотикам, **это другое исследование с другой методологией**. В нашем исходном докладе они долго шли вместе, и это была ошибка. Теперь разведено.

Клозапиновые запоры (CIGN). Every-Palmer S. et al. (EBioMedicine 2016): 80 % пациентов на клозапине имеют колоническую гипомотильность. Летальность 15–27,5 %. **Кухня не отвечает за это, но обязана знать: внезапное прекращение приёма пищи + боль в животе + рвота у жителя на клозапине — повод для немедленного вызова врача**.

Загущённые жидкости. Steele S.J. et al. (Breathe 2021): «нет убедительных данных о снижении респираторных осложнений, но есть нагрузка лечения и снижение потребления жидкости». Загущение **не решает проблему аспирации** — это организационная мера с доказанной историей. **«Загустить и забыть» — худшая стратегия**.

[Слайд 5 — Клинические факты; 9:30]

[10:00] Правовая рамка: что разрешено и что не нужно

Правовая рамка. Федеральное право не запрещает и не обязывает вариативное питание. Это организационная модель в рамках действующего закона.

442-ФЗ (ред. от 26.12.2024, вступ. в силу с 01.03.2025) — право на «уважительное и гуманное отношение» (ст. 9 п. 1), ИППСУ «исходя из потребности гражданина» (ст. 16), предельная плата 75 %

среднедушевого дохода (ст. 32 ч. 4). **Ни одна статья не говорит «вы обязаны предоставить выбор из N блюд ежедневно».**

Закон 3185-1 (ред. от 22.07.2024) — ст. 5 ч. 2: «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства». Ст. 37 — права пациентов психиатрических стационаров. Ст. 43 — права лиц в стационарных организациях для лиц, страдающих психическими расстройствами. **Эти права принадлежат жителю, а не учреждению.**

СанПиН 3590-20 (пост. от 27.10.2020 № 32) — действует до 31.08.2026. П. 7.1.11: «не менее 3-х раз в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям». **СанПиН 4282-26** (пост. от 02.06.2026 № 18) — вступает в силу с **01.09.2026**, через 6 дней после семинара. Формулировка «не менее 3-х раз в день» сохранена, но технические требования могут отличаться.

Приказы Минздрава 330н и 395н — нормы лечебного питания. **Адресованы медицинским организациям, не стационарным организациям социального обслуживания.** Это организационная граница, требующая правовой проверки на местном уровне.

44-ФЗ и 223-ФЗ. Бюджетные учреждения — 44-ФЗ (Тесовый берег). Автономные — 223-ФЗ (Серафимовский). **Обе схемы допускают вариативность, если она в ТЗ. Это место, где вариативность становится обязательством подрядчика.**

И главный правовой аргумент директора при проверке — не «закон не запрещает» (формула слабая), а **комплект документов:** положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. С комплектом — как управленческое решение.

[Слайд 6 — Правовая рамка; 12:00]

[12:30] Российские практики: 4 учреждения + 1 регион

Теперь — про то, что уже работает в России. **Без обобщений. 4 учреждения и 1 региональная модель.**

Серафимовский — наш дом, Санкт-Петербург. Локальный приказ № 124 от 10.03.2026 (правила внутреннего распорядка) закрепил заказное питание. **Локальный акт одного учреждения, не общероссийская норма.** Сайт www.pni9.ru прекратил работу 21.08.2026, домен истёк; текст правил — в архивной копии web.archive.org. **Приказ — пример того, как может быть, не руководство к действию для других ДСО.**

Успенский психоневрологический интернат, Новосибирская область — модель М2: во всех отделениях, ежедневно два вторых, два салата, два напитка. Это полная ежедневная вариативность по вторым блюдам. Опубликовано 13.08.2024.

Болотнинский ПНИ, та же область — модель М1: выбор на завтрак и обед по ключевым позициям, перечень определяет диетсестра. Не путать с Успенским — это два разных учреждения, два разных подхода.

Усть-Илимский дом социального обслуживания, Иркутская область — программная публикация «что за зверь такой — вариативное питание». Методический разбор.

Иркутская область в целом — региональная модель: выбор из двух первых, двух вторых и гарниров. Масштабирование на регион.

«Тесовый берег» — наш со-модератор Тимур Аликович Нурбаев, директор СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“». Площадка № 2 семинара. **Его практика пока не опубликована** — не путать с пятью подтверждёнными кейсами. «Победа», «Парус» — учреждения программы 27.08, не смешивать с практиками.

Что общего у всех 4 кейсов. Вариативное питание введено без повышения платы для жителей — за счёт перераспределения продуктовой корзины, отказа от «несъедаемых» позиций и снижения отходов. **Но это не автоматически — это требует семидневного замера в каждом учреждении.** «Национальной доли отходов нет» — её даёт семидневный замер в пилоте, не лозунг.

[Слайд 7 — Практики; 14:30]

[15:00] Пилот 90 дней: минимальный безопасный старт

Пилот за 90 дней реалистичен на одном отделении без новой сметы. Три фазы: 30 дней замер → 30 дней документы и обучение → 30 дней пилот.

Фаза 1 (дни 1–30). Приказ о рабочей группе. Сырьевая строка (расход / жители / дни). Семидневный замер отходов. 5 чисел контингента (сколько едят сами / с помощью / неговорящие / группа риска дисфагии / на весогенных препаратах). Таблица врача «лекарство × еда». **Что не делается** — не менять меню, не выбирать модель, не выпускать пресс-релиз.

Фаза 2 (дни 31–60). Утверждение «Положения об организации питания». Согласование с учредителем (получить письменное «да»). Формирование 3–4 пар эквивалентов (подписаны врачом и диетсестрой). Обучение смены — **минимум 8 часов на сотрудника.** Журналы заказа, отказов, отходов.

Обучение повара IDDSI-тесту. **Что не делается** — не масштабировать, не менять закупку.

Фаза 3 (дни 61–90). Запуск выбора. Ежедневный сбор данных. Промежуточный контроль на 75-й день. Итоговый замер на 90-й. Решение о корректировке или масштабировании.

5 групп показателей: заполненность пищевых карт; доля приёмов с реально доступным выбором; доля корректно исполненных заказов; отказы, замены и пищевые отходы; события риска. **Полный словарь 26 показателей** — у нас в инструментах.

6 стоп-критериев: рост пневмоний ≥ 30 %; падение со смертельным исходом в столовой; жалоба в прокуратуру; приказ учредителя; отзыв согласия учредителя; отсутствие врача. **«% выбравших» — не KPI.** Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора.

Лучше «сложное» отделение — с группой помощи, неговорящими. Если получится у них — получится у всех. **Внедрено публично ≠ доказанный эффект.** Пилот в вашем учреждении — единственный способ получить собственные данные.

[Слайд 8 — Пилот 90 дней; 18:00]

[18:00] Метрики и стоп-критерии в деталях

Подробнее про метрики. Главная ловушка — счёт «% выбравших». Этот процент **ничего не говорит** о качестве пилота. Человек вправе выбрать стандартный вариант. Человек вправе не выбирать вовсе. Успех — **доступность и исполнение осмысленного выбора.**

Группа 1. Заполненность пищевых карт. Числитель — число жителей с заполненной картой. Знаменатель — общее число. Целевой диапазон 70–100 %. **100 % карт ≠ 100 % правильно заполненных; нужна проверка качества.**

Группа 2. Доступный выбор. Числитель — число обедов с 2 вариантами. Знаменатель — все обеды. Целевой 80–100 %. Число утверждённых пар эквивалентов — не менее 3.

Группа 3. Исполнение. Числитель — точно поданные заказы. Знаменатель — все заказы. Целевой 85–100 %; важен **тренд**, не абсолют. Заказы с правильной текстурой — 90–100 %.

Группа 4. Отходы. Средние тарелочные остатки в граммах на человека. Доля приёмов с отказом ≥ 50 % — целевой ≤ 20 %. Кухонные остатки — целевой 30–80 г/чел./день (снижение относительно базового замера). Замены по таблице пар — 5–25 %.

Группа 5. События риска. Пневмонии — на 1000 жителе-дней, целевой ≤ 2 . 0 за 90 дней не гарантировано; цель — отсутствие роста. Падения и инциденты — сравнение с предыдущим кварталом. Отказы ≥ 3 дней — каждый случай → врач в тот же день. Обезвоживание — особенно у жителей на загущённых жидкостях.

Стоп-критерии — это красные линии, через которые не переступаем. Рост пневмоний на 30 % за квартал — остановка, анализ. Падение со смертельным исходом в столовой — остановка, расследование. Жалоба в прокуратуру — остановка, разбор. **Это не отказ от пилота — это пауза до устранения причины.**

[Слайд 9 — Метрики и стоп-критерии; 20:30]

[21:00] Пять возражений и честные ответы

Возражение первое: «Закон не запрещает, но и не обязывает. Зачем нам это?» Затем, что ответ проверяющему — комплект документов, не формула «запрета нет». Проверяющий не спрашивает «а нет ли запрета?», проверяющий спрашивает «а покажите положение, журнал, карты». Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. С комплектом — как управленческое решение.

Возражение второе: «Клозапин и кофе — это к нам не относится». У вас есть жители на антипсихотиках. **76,3 % прибавка веса на клозапине за 38 нед** (Campforts 2023, 202 исследования). Это не все, но это риск. Одна подписанная таблица на посту — таблица «лекарство × еда» — закрывает тему.

Возражение третье: «99 % под опекой учреждения — конфликт интересов». Да, и это не уникальный риск, а общероссийская норма. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 говорит о праве на гуманное отношение. **Этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают.** Решение — задокументированный процесс выражения воли, не юридическая реформа.

Возражение четвёртое: «СанПиН меняется через 6 дней, мы не успеем». Успеете. Главное для учреждений соцобслуживания — п. 56 подп. 11. Формулировка «не менее трёх приёмов + диетическое по показаниям» сохранена в обеих редакциях. **Через 6 дней после семинара смотрите новую редакцию** — у нас в библиографии v2 есть прямая ссылка.

Возражение пятое: «У нас 1000 коек, пилот на отделении — капля в море». Пилот на 20–35 жителях — это **доказательство работоспособности модели в вашем учреждении**. Масштабирование — после 90 дней успеха. **Внедрено публично ≠ доказанный эффект.** Панелей «до/после» в открытом доступе почти нет — даже у 4 опубликованных российских практик.

[24:00] Защитная формула и первые пять действий

Защитная формула, если спросят «с чего начать прямо сейчас».

1. **Семь дней считаем отходы.** Приложение 25. Без замера через 90 дней сравнивать нечего.
2. **Замеряем интервал ужин → завтрак** одной строкой в журнале. Если >13 часов — сдвигаем расписание. 11 часов — шведский ориентир Livsmedelsverket; 14 часов — американский CMS F-Tag 803. Российского норматива нет.
3. **На пост — таблица врача «лекарство × еда».** Не самодеятельность кухни. Приложение 21.
4. **Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день.** Приложение 9.
5. **Если кухня чужая — открыть спецификацию:** есть ли строка выбора? Разделы 42 и 35.9.

В первый понедельник не делать: не выбирать модель M1–M5, не менять меню, не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается на этапе пар эквивалентов.

Через 7 дней на руках: сырьевая строка (1 час, калькулятор), замер отходов запущен (10 минут), приказ с пятью фамилиями (30 минут), письмо учредителю (30 минут), выбранное отделение (1 час с заведением). **Это пять действий за два часа.** Новой сметы не нужно. Меню не трогают.

[26:00] Какие ошибки делают чаще всего

Десять ошибок, которые я видел у коллег.

1. **Запустить без обучения смены.** Пилот без 8 часов обучения на сотрудника — деньги на ветер.
2. **Измерить «% выбравших» и решить, что пилот не удался.** Это не KPI. Успех — доступность.
3. **Подождать приказа учредителя, а не согласовать.** Уведомить, не запрашивать разрешения.
4. **Загустить жидкости «на всякий случай».** «Загустить и забыть» — худшая стратегия. Текстура напитка — врач, с пересмотром.
5. **Запретить кофе жителям на клозапине.** Кухня не отменяет. Врач оценивает и документирует.
6. **Выбрать «удобное» отделение для пилота.** Лучше «сложное» — с группой помощи. Если получится у них — получится у всех.

7. **Подать расширенный отчёт о пилоте без измеримых данных.**
Сначала цифры, потом — нарратив.
8. **Считать «вариативность бесплатной» или «вариативность дорогой на 30 %».** Без семидневного замера — не знаем.
9. **Смешать 5 подтверждённых практик с «Тесовым берегом».** Это 4 разных учреждения с разными моделями + 1 со-модератор, чья модель не опубликована.
10. **Считать, что «внедрено публично = доказанный эффект».** Это разные вещи.

Главная ошибка из всех — выбрать самое удобное отделение, а не самое сложное. Если у вас не получится на «сложном» — вы не сможете масштабировать. Если получится на «сложном» — масштабирование будет простым.

[Слайд 12 — 10 ошибок; 28:00]

[28:00] Дорожная карта: 12 месяцев

Что дальше — после пилота 90 дней.

Месяцы 1–3 (пилот). Один обед, одно отделение, одна неделя замера → 90 дней пилота. 5 групп показателей. 6 стоп-критериев.

Месяцы 4–6 (масштабирование). Если 4–5 из 5 групп в норме — расширение на 1–2 отделения. Дополнительное обучение. Корректировка пар.

Месяцы 7–9 (интеграция). Включение вариативности в «Положение об организации питания» на уровне учреждения. Согласование с учредителем как **постоянной** практики, не пилота. Обновление контракта на аутсорсинг (если применимо).

Месяцы 10–12 (тиражирование). Методические материалы для других учреждений региона. Доклад на конференции. Публикация в профессиональном журнале. Презентация опыта на семинарах.

Главный риск 12-месячной программы — потеря темпа после успешного пилота. **Если пилот прошёл — это не конец, а начало.** Масштабирование требует тех же усилий, что пилот, плюс новые (согласование с другими отделениями, новые помощники, новые врачи).

[Слайд 13 — Дорожная карта; 30:00]

[30:00] Этический фокус: достоинство

Отдельный разговор про достоинство. Вариативное питание — это не только клиническая и управленческая задача. Это этическая задача.

«Невербальный выбор» — термин авторский. В международной практике используется «выражение воли без слов» или «поддержанное принятие решения» по КПИ ст. 12. **Это не фикция.** Для значительной доли жителей — неговорящих, маломобильных, в постельном режиме — это единственный канал воли. Закрыть его — значит превратить жителя в объект заботы.

99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения — и это означает, что учреждение одновременно опекун и поставщик услуг. **Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2** говорит о праве на «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства». Этот текст работает в любой конфигурации, но требует процессуальной поддержки — пищевой карты, журнала выбора, совета жителей.

Шесть измерений стола — достаточность, безопасность, удовольствие, социальность, самостоятельность, выбор. **Только последнее — выбор — нельзя делегировать.** Всё остальное можно сделать за человека, решение — нет.

[Слайд 14 — Этика; 32:00]

[32:00] Международный контекст (кратко)

Что есть в мире (кратко, для ориентира).

Онтарио (Канада) — О. Reg. 246/22, 3-разовое питание, цикл 21 день.
США — 42 CFR §483.60, CMS F-Tag 803, ночной интервал не более 14 часов.
Швеция — Livsmedelsverket, не более 11 часов ночного интервала, обязательная пищевая биография.
Германия — DGE-QST, 4-недельный цикл, «осознанный риск» при дисфагии.
Австралия — Aged Care Quality and Safety Commission, Standard 4, достоинство подачи текстур.
Великобритания — BDA, единственное (по нашим данным) профессиональное руководство по питанию в психиатрических стационарах.

Общий принцип: безопасность (3-разовое питание, текстуры, медицинские ограничения) + выбор (внутри медицинской рамки) + документирование (биография, журналы, согласование).

Чего нет в мире — доказательной базы эффективности вариативного питания **в психиатрическом контингенте.** Исследования есть в aged care (Wu 2022), в dementia (Nijs 2006), в frailty (Yoneyama 2002). Прямого переноса на ПНИ нет. **Пилот в вашем учреждении — единственный способ получить собственные данные.**

[33:30] Заключение: не внедряйте вслепую. Измеряйте.

Коллеги, **главный практический вывод**: «Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания.

Что мы обсудили:

- Контекст: 466 ПНИ, 139 000 жителей, 99 % под опекой учреждения.
- Проблема: пять конфликтов за одним обедом.
- Граница 4.0: что кухня не назначает.
- Клиника: дисфагия, антипсихотики, гигиена полости рта, клозапиновые запоры.
- Право: 442-ФЗ, 3185-1, СанПиН 3590/4282.
- Практика: 4 учреждения и 1 регион в России.
- Пилот: 3 фазы, 5 групп показателей, 6 стоп-критериев.
- Возражения: 5 типичных, с честными ответами.
- Действия: 5 первых шагов за 2 часа.
- Этика: невербальный выбор, достоинство, опека.

Если получилось в Успенском ПНИ — жители «с лёгкостью освоили новую систему» — это методика. **Если не получилось в вашем учреждении** — это тоже результат, который говорит, что нужно менять в вашей системе. Не в системе «вообще».

Главная финальная формула: «Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки».

Спасибо. Готов ответить на вопросы.

Тайминг

Блок	Минута	Содержание
Вступление	0:00–0:30	Титул
Контекст	0:30–2:00	466 ПНИ, 139 000, 99 % опеки
Проблема	2:00–5:00	Пять конфликтов
Граница 4.0	5:00–7:00	Что кухня не назначает
Клиника	7:00–10:00	Дисфагия, антипсихотики, гигиена, запоры
Право	10:00–12:30	442-ФЗ, 3185-1, СанПиН

Блок	Минута	Содержание
Практика	12:30– 15:00	4 учреждения + 1 регион
Пилот	15:00– 18:00	3 фазы, 5 групп, 6 стоп-критериев
Метрики	18:00– 21:00	5 групп в деталях
Возражения	21:00– 24:00	5 типичных
Защитная формула	24:00– 26:00	5 действий
10 ошибок	26:00– 28:00	Самые частые
Дорожная карта	28:00– 30:00	12 месяцев
Этика	30:00– 32:00	Невербальный выбор, достоинство
Международный контекст	32:00– 33:30	Онтарио, США, Швеция, Германия, Австралия, Великобритания
Заключение	33:30– 35:00	Главный вывод + формула

Всего: 35 минут (для версии 30 мин — сократить один из блоков 4–5; для версии 40 мин — добавить разбор кейса).

Версии

- **30 мин** — основной доклад для 25.08 (третий день семинара, общая сессия).
- **35 мин** — стандарт для 26.08 (дискуссия по питанию, со-модератор Нурбаев).
- **40 мин** — расширенный для тренеров / методистов (с разбором кейса и дорожной картой).

Оговорки (те же, что в 20-мин версии)

1. «74 %» — данные проекта «Если быть точным», не Минтруд.
2. «15 часов» — пример, не средний показатель по РФ.
3. «76,3 % клозапин» — Campforts 2023, не Pillinger 2020.
4. «Клозапин + кофе +19 %» — Hägg 2000, 12 здоровых добровольцев, однократная доза.
5. «IDDSI 44→90 %» — общее aged care, не психиатрия.
6. «1/10 смертей» — Sjogren 2008, frail elders, не ПНИ.
7. Приказ № 124 — локальный акт Серафимовского.

8. СанПиН 4282-26 — вступает в силу 01.09.2026.

9. «Внедрено публично ≠ доказанный эффект» — панелей «до/после» в открытом доступе почти нет.

Дата: 22.08.2026. **Докладчик:** Чистяков Евгений Владимирович. **Объём:** ≈ 4 800 слов. **Время:** 30–40 минут (варианты). **Слайды:** 16 (включая 5 резервных для Q&A). **Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки.**